**جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) ***

# طلب علاج أول مرة / متردد

**إسم المريض رباعياً :** السيدة احمد احمد ابو رقعة
**المحافظة :** القليوبيه **الحي / المدينة :** بنها **العنوان :** طنطا
**رقم البطاقة :** 26507201600362 **رقم التليفون :** 01119185400 **تاريخ تسجيل الإستمارة :** 20-10-2026
**العمر(تاريخ الميلاد) :** 20-07-1965 **المهنة :** ربه منزل

## الإقرار

**أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:-التأمين الصحي-القوات المسلحه-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك**

**الإخصائي الاجتماعي** **المقر بما فيه**
**التوقيع:**(----------) **التوقيع:**(----------)

**التشخيص الإكلينيكي :** سرطان بالثدي (مبادرة)
**نتائج الأبحاث :** (مرفق)
**التشخيص النهائي :** سرطان بالثدي (مبادرة)
**خطة العلاج :** أبحاث أورام مزيد من الابحاث و الاشعات [7954] **قسم العلاج :** الاورام
**التعليق على التشخيص :** ----------

## تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

**الاسم:** د/محمد كيلاني **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
**الاسم:** د/ندى حسن **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
**الاسم:** د/نرمين رمضان **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------

**أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية.**
**كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.**

**تعتمد صحة البيانات المرفقة**
**رئيس اللجنة و مدير المستشفي.**

**تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفي قبل الصرف.**

## أعضاء اللجنة

**ا.د/** ---------- **ا.د/** ---------- **د/** ---------- **د/** ----------

## قرار اللجنة

**التشخيص النهائي :** ----------
**خطة العلاج :** ----------
**المستشفي :** ----------**قسم :** ----------
**جهة العلاج :** ----------**نفقات :** ----------
**ملاحظات :** ----------

| رئيس | مدير عام | ختم |
|---|---|---|
| المجلس الطبي المتخصص | مديرية الشئون الصحية | شعار الجمهورية |

Name: السيدة احمد احمد ابو رقعة
National ID: 26507201600362

GUSTAVE ROUSSY INTERNATIONAL EGYPT

## تقرير طبي

السيد

تحية طيبة وبعد,,

| | |
|---|---|
| إيماء للطلب المقدم من | بشأن تقرير طبي للمريض |
| بقسم: | رقم طبي: |

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

| | |
|---|---|
| تاريخ وساعة الدخول :<br>-- --:-- yyyy-mm-dd | تاريخ وساعة الخروج :<br>PM 01:17 05-07-2026 |

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انة

المريضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي Further investigations and imaging

| | |
|---|---|
| التاريخ :<br>05-07-2026 | الوقت :<br>-- --:-- |
| | الطبيب المعالج :<br>د/شيماء لاشين |

جمهورية مصر العربية
بطاقة تحقيق الشخصية



السيده
احمد احمد ابورقعه
بلوك١٦٦-مساكن اسكندرية-مدخل ب
المقطم - القاهره

٢٦٥٠٧٢٠١٦٠٠٣٦٢

LR3637876

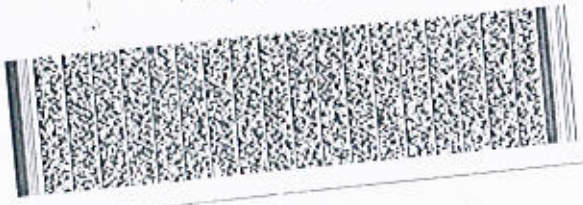


٢٦٥٠٧٢٠١٦٠٠٣٦٢ ٢٠٢٦/٠٣
بدون عمل

أنثى مسلمة أرملة

البطاقة سارية حتى ٢٠٣٣/٠٣/٣٠





| | |
|---|---|
| **Name:** السيده احمد احمد ابو رقعه | |
| **MR. :** 8274 | |

Detailed Medical Report

**السيد**

**تحية طيبة وبعد,,**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **إيماء للطلب المقدم من** | | **بشأن تقرير طبي للمريض** | |
| **بقسم:** | | **رقم طبي:** | |

**ننشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تاريخ وساعة الدخول :** | | **تاريخ وساعة الخروج :** | |

**وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه**

**The patient is a 60-year-old female with a history of left breast invasive ductal carcinoma, grade II, estrogen receptor 8/8 positive, progesterone receptor 5/8 positive, HER2 3+, Ki-67 20%. Staging at diagnosis was cT4bN2M0. She received neoadjuvant chemotherapy (CT4bN2M0) followed by a total of six cycles of taxane-based chemotherapy (TC*6) and four cycles of HER2-targeted therapy (HP*4). She subsequently underwent left modified radical mastectomy on 21 January 2023. Pathology showed residual disease with 2 of 9 lymph nodes positive (pPR YPT2YPN2). Since March 2023, she has been maintained on KADCYLA (ado-trastuzumab emtansine) and oral aromatase inhibitor therapy (FEMARA). Current plan includes continuation of endocrine therapy and HER2-directed maintenance.**

**Pending investigations for FEMARA therapy and supportive care are scheduled, with the next follow-up planned in three months.**

**A new bone scan (BSM) without metastatic lesions and a CT of the chest, abdomen, and pelvis demonstrated hepatic cysts that have remained stable since May 2025. Follow-up for zoledronic acid (Zometa) will be performed after calculation of creatinine clearance (CrCl 1.25 L/min) and serum creatinine, with continuation of FEMARA.**

**تحريرا في ,**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **التاريخ :** | **20-09-2026** | **الوقت :** | |

**الطبيب المعالج :** **ايه مدحت بدوي محمد**

**يعتمد ,**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Patient Name | : الأستاذه / السيده احمد ابو ركبه | Request No. | : 13006514 |
| Patient No. | : 26507201600363 | Request Date | : 23/01/2023 |
| Path No. | : 204/2023 | Verification Date | : 05/02/2023 |
| Sex | : Female | Financial Category | : ام دار السلام - ثقة الدولة |
| Age | : 57 Y | Department | : Out Patient |
| Referreing Doc : | | Registered by | : .marwa mohamed youss |

## Pathology Report

Clinical Data:
Left breast cancer post NACT
Nature of the specimen:
Left MRM
Gross Examination:
- Procedure: Left MRM specimen measured 26x20x5 cm , covering skin ellipse measured 20x15.5 cm .
- Tumor extent : An ill defined greyish white rubbery to firm tumour bed site measured 5x3.5x2 cm .
- Skin involvement: Nipple and areola were unremarkable grossly
- Distance from margins: 1.5 cm away from deep margin and 1 cm away from the skin
- Lymph nodes number and size: 15 LNs up to 2x1.5 cm

Microscopic examination:
- Histological type: Invasive duct carcinoma ( cellularity 20%)
- Grade (differentiation+ nuclear pleomorphism + mitosis): G II(3+2+1)
- Angioinvasion: Positive.
- Ductal carcinoma in situ: Positive
- Skin involvement: Free nipple and areola
- Lymph node involvement: Positive metastatic deposits in 9 LNs ( 9/15) , with extra nodal extension
- Resection Margins: Free deep margin
- Histologic response to therapy: Pathologic partial response

Diagnosis:
Left breast cancer , Left MRM :
- Invasive duct carcinoma grade II ( cellularity 20%)
- Positive DCIS

Verified by :
dr.esraa magdy

| | | | |
|---|---|---|---|
| Patient Name | : الأستاذه / السيده احمد احمد ابو ركيه | Request No. | : 13006514 |
| Patient No. | : 26507201600363 | Request Date | : 23/01/2023 |
| Path No. | : 204/2023 | Verification Date | : 05/02/2023 |
| Sex | : Female | Financial Category | : برنامج دار السلام - تكلفة الدولة |
| Age | : 57 Y | Department | : Out Patient |
| Referreing Doc : | | Registered by | : .marwa mohamed youss |

## Pathology Report

- Free deep margin
- Free nipple and areola
- Positive metastatic deposits in 9 LNs ( 9/15) , with extra nodal extension
- Pathologic partial response
- Stage : ypT2, ypN2

Dr. Walaa Ghoniem

Prof. Dr. Manal Elmahdy

Verified by :
dr.esraa magdy

Ministry Of Health
Specialized Medical Centers
Dar El Salam Cancer Hospital
Radiology Department

وزارة الصحة والسكان
منشآت المراكز الطبية المتخصصة
مستشفى أورام دار السلام
ادارة الاشعة

| | |
|---|---|
| Patient Name: Al Sayeda Ahmed Ahmed Aborkah | Date : 11/05/2025 |
| Exam : CT CAP+C (CT Chest Abd. Pelvis) | Age : 60 Year(s) |
| Medical ID: 2408/2022 | Pat. ID: 12853 |

## ***POST CONTRAST MULTI-SLICE CT SCAN OF THE CHEST, ABDOMEN & PELVIS REVEALED: -***

***↓ Compared to previous study dated 6/01/2025:***

### *1. Chest:*

- Status post left MRM showing no operative bed masses or collections.
- **Rather stationary course of the previously noted** few bilateral pulmonary nodules the largest in middle lung lobe measuring about 6 mm.
- Few scattered bilateral thin atelectatic bands.
- No pathological hilar or mediastinal lymph nodes.
- No evidence of pleural effusion or masses seen.
- Average cardiac size. No pericardial effusion detected.
- Normal CT appearance of the thoracic aorta and the great vessels.

### *2. Abdomen and pelvis:*

- The liver is mildly enlarged in size showing stable bilobar non enhancing cystic focal lesions, the largest one is seen at left hepatic lobe segment II measures about 3.8 x 3 cm.
- Patent homogenously enhancing portal vein and is main branches as well as its main tributaries.
- No intra-hepatic or extra-hepatic biliary radicles dilatation.
- Normal size & parenchymal texture of the spleen with no focal lesions seen.
- No pathological abdominal or pelvic lymph nodes.
- Normal size, parenchymal thickness & density of both kidneys with no stones or back-pressure changes. Left renal cortical cyst is noted.
- **Stable** left adrenal hypodense lesion measuring 2.7 cm mostly adenoma.
- Normal appearance of the pancreas, aorta, I.V.C and right supra-renal.
- Smooth filling of the urinary bladder with no filling defects or diverticular outpouching.
- Normal appearance of the other pelvic organs.
- No abdominal or pelvic masses or collections.

Ministry Of Health
Specialized Medical Centers
Dar El Salam Cancer Hospital
Radiology Department

وزارة الصحة والسكان
الهيئة المراكز الطبية المتخصصة
مستشفى أورام دار السلام
ادارة الاشعة

| Patient Name: Al Sayeda Ahmed Ahmed Aborkah | Date : 06/01/2025 |
|---|---|
| Exam : C.T CHEST WITH CONTRAST | Age : 59 Year(s) |
| Medical ID: 2408/2022 | Pat. ID: 12853 |

- Normal appearance of the other pelvic organs.
- No abdominal or pelvic masses or collections.

3. ***The scanned skeleton:***
   - No suspicious lytic or sclerotic osseous deposits.
   - **Stable** osteitis pubis and bilateral chronic sacroiliitis appearance.
   - No vertebral structural collapse or extra-osseous soft tissue component.

***OPINION:***

- ***Newly developed middle lung lobe small subpleural pulmonary nodule, for follow up.***
- ***Otherwise, stationary course rest study.***

*Dr. Walid Mohamed, M.D.*